

# 癌症期別 Stage 1、2、3、4 怎麼分？AJCC 9th 實證版

*Cancer staging explained: AJCC 9th edition and same-stage heterogeneity*

林協霆, MD, 內科專科醫師, 腫瘤內科專科醫師

醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院 腫瘤內科部 · ORCID: [0009-0002-3974-4528](https://orcid.org/0009-0002-3974-4528)

發表日期：2026/05/11 · 審稿：林協霆 (2026/05/11) · 主題：癌症 TNM 分期 (Cancer TNM staging)

DOI: 10.5281/zenodo.20112703 · 此版本 10.5281/zenodo.20112704 ·

<https://lin.hsiehting.com/posts/2026/cancer-staging-ajcc-9-explained/>

## 摘要 · ABSTRACT

第四期不等於末期；AJCC 9 版（2024–2026 陸續上路）以肺癌、鼻咽癌、神經內分泌瘤領銜更新，並把預後分期擴展到乳癌、攝護腺、頭頸癌，本文用病人語言解釋 TNM 邏輯、同期不同預後的原因與 nomogram。

**第四期不等於末期。** 癌症分期最常見的誤解，是把「Stage IV」直接讀成「臨終」。AJCC 第 9 版（Version 9）從 2024 年的神經內分泌瘤、外陰癌起跑，2025 年 1 月起依序更新肺癌、胸腺、肋膜間皮瘤、鼻咽癌等癌別；同時延續 8 版以來「預後分期（prognostic stage）」的精神，把腫瘤分級、荷爾蒙受體、HER2、PSA 等生物標記納入計算，讓乳癌、攝護腺、頭頸癌的同期病人預後可以細分。本文用病人語言解釋 TNM 三個字母、Stage 0–IV 的邏輯、同一期為什麼預後差很多、以及 NCCN/MSKCC nomogram 怎麼補足分期表的不足。

## 閱讀對象

本文設定讀者為剛拿到病理報告、想看懂「為什麼是第幾期」「同期病人預後差別怎麼來」的病友與家屬，以及對 AJCC 9 版分癌別更新進度有興趣的同業。任何治療決策請依您的主治醫師個別判斷。



## TNM：三個字母先看懂

AJCC/UICC 全球共用的分期語言，是 TNM 三個欄位：

| 欄位 | 中文    | 內容          | 範例                        |
|----|-------|-------------|---------------------------|
| T  | 原發腫瘤  | 腫瘤大小或侵犯深度   | T1（小於 2 cm）vs. T4（侵犯鄰近器官） |
| N  | 區域淋巴結 | 是否轉移、數目、位置  | N0（沒有）vs. N3（廣泛侵犯）        |
| M  | 遠端轉移  | 是否擴散到肝、肺、骨等 | M0（無）vs. M1（有）            |

不同癌別的 T、N、M 細節定義不同——例如乳癌的 T1 是「腫瘤 ≤ 2 cm」，肺癌的 T1 是「腫瘤 ≤ 3 cm 且無胸膜侵犯」，鼻咽癌的 T1 則是「侷限於鼻咽或鼻咽腺樣體」。AJCC 9 版（2024–2026 陸續實施）的主要改動之一，就是把這些 T、N、M 的判讀標準寫得更精細，例如：

- **肺癌 9 版**（2025/1 上路）：把 N2 細分為 N2a（單一站轉移）與 N2b（多站轉移），M1c 再依轉移器官數目分為 M1c1、M1c2。
- **鼻咽癌 9 版**（2024/10 公布）：T3 必須是「明確的骨皮質破壞或骨髓侵犯」；影像可見的淋巴結外侵犯（ENE）併入 N3；M1 依轉移病灶數目分為 M1a（≤3 個）與 M1b（>3 個）。
- **神經內分泌瘤 9 版**（2024）：胃腸胰 NET 與 MEN1、VHL 等遺傳症候群相關 NET 的分期標準明確化，並把 T1NXM0 納入 Stage I。

### 從 TNM 到 Stage 0–IV

T、N、M 分別寫好後，把三者組合查表，就會得到 Stage 0、I、II、III、IV。這是「**解剖分期**」（anatomic stage）——只看腫瘤跑了多遠。大致對應：

| 期別        | 含意（一般原則，依癌別調整）      | 治療目標                            |
|-----------|---------------------|---------------------------------|
| Stage 0   | 原位癌（in situ），未穿透基底膜 | 局部切除即可治癒機率高                     |
| Stage I   | 腫瘤小、淋巴結陰性、無遠端轉移     | 局部治療為主（手術 ± 放療）                 |
| Stage II  | 腫瘤較大或有侷限淋巴結轉移、無遠端轉移 | 局部治療 ± 輔助性化療／標靶                 |
| Stage III | 腫瘤侵犯深、淋巴結較廣或鄰近器官受侵犯 | 多模式治療（手術 + 放療 + 系統性治療）          |
| Stage IV  | 已有遠端轉移（M1）          | 系統性治療為主；oligometastatic 可考慮局部治療 |

跨癌別比較注意  
不同癌別的「同一期」預後可能差異極大。例如同樣是 Stage III，HER2 陽性乳癌經完整治療 5 年總存活率可達 80% 以上，但 Stage III 胰臟癌或膽管癌中位存活仍多在 12–18 個月。**請不要拿親友的「我也是第三期」來推估自己的預後，要回到自己的癌別、生物標記與治療反應。**

### 解剖分期 vs. 預後分期：8 版以來的大變革

AJCC 8 版（2018 年實施）首次在乳癌引入「預後分期」（prognostic stage）：除了 T、N、M，還納入腫瘤分級（grade）、荷爾蒙受體（ER、PR）、HER2、以及 21-基因 Oncotype DX 分數。9 版延續並擴展這個思路到攝護腺癌、頭頸癌等癌別。

| 項目     | 解剖分期 (anatomic)      | 預後分期 (prognostic)                                                            |
|--------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 計算依據   | T、N、M                | T、N、M + 分級 + 生物標記 (依癌別)                                                      |
| 使用情境   | 全球流行病學、癌登、跨國比較       | 臨床預後預測、治療強度決策                                                                |
| 乳癌例子   | T2N0M0 一律是 Stage IIA | T2N0M0 + grade 1 + ER+/HER2- → Stage IB ; T2N0M0 + grade 3 + 三陰性 → Stage IIB |
| 攝護腺癌例子 | T2cN0M0 是 Stage II   | 加入 Gleason grade group 與 PSA 後可細分 IIA/IIB/IIC                                |
| 頭頸癌例子  | HPV 陽性與陰性混在一起        | HPV+ 口咽癌另立分期表 (HPV-mediated stage I-IV)                                      |
| 預後鑑別力  | 中等                   | 較佳; JAMA Oncol 驗證乳癌預後分期 5 年 BCSS 區辨優於解剖分期                                    |

為什麼要兩套分期？

解剖分期是全世界癌症登記與政策的共同語言（不需要病理染色設備也能算），預後分期則是臨床上預測「這個病人未來會怎麼走」的工具。AJCC 9 版同時保留兩套，是讓資源不同的國家／醫院都能用得上。

## 同一期，為什麼有人活得短？

這是門診最常被問到的問題。同樣 Stage II 乳癌、同樣 Stage III 大腸癌，5 年存活率可能差到 30–40%，原因可拆成 4 大類：

1. **生物標記與分子亞型** — 乳癌的 ER/PR/HER2/Ki-67、肺癌的 EGFR/ALK/KRAS、大腸癌的 MSI/RAS/BRAF、攝護腺癌的 Gleason grade group、淋巴瘤的 IPI/GCB vs. ABC，都不在 T、N、M 之中，但對預後與治療選擇影響極大。
2. **腫瘤分級 (Grade)** — 高分化 (grade 1) vs. 低分化 (grade 3) 腫瘤即使 T、N 一樣，惡性度與復發風險差很多。AJCC 8、9 版在乳癌、攝護腺、軟組織肉瘤等癌別把分級納入預後分期。
3. **病人因素** — 年齡、ECOG 體能狀態、共病（糖尿病、慢性腎病、心衰）、營養狀態，會影響能否完成標準治療。能完成完整治療的 Stage III 病人，預後通常優於只能做減量治療的 Stage II 病人。
4. **治療反應** — 新輔助化療 (neoadjuvant) 後是否達到病理完全反應 (pCR)、輔助治療能否如期完成、是否復發等，是臨床上最強的預後因子之一。

## 拿到病理報告：怎麼讀懂分期欄位

### 第一步 — 找到 pT、pN、cM 三個欄位

病理報告上會看到例如「pT2N1M0」或「ypT1cN0」字樣。前面的 p 代表「pathological」（術後病理確認），c 代表「clinical」（影像／理學檢查推估），y 代表術前接受過新輔助治療。手術前的分期叫 cTNM，手術後叫 pTNM——兩者可能不同（最常見：影像看起來 N0，但手術病理發現 N1）。

### 第二步 — 看分級 (grade) 與生物標記

乳癌看 ER／PR／HER2／Ki-67 與 grade；攝護腺看 Gleason grade group 與 PSA；大腸癌看 MSI／MMR；肺癌看 PD-L1、EGFR、ALK、KRAS、ROS1；頭頸癌看 HPV／p16；淋巴瘤看細胞起源。如果報告上沒有這些欄位，主動問主治醫師「我有做哪些 biomarker？結果是什麼？」

### 第三步 — 算出（或請醫師算出）解剖期 + 預後期

AJCC 8、9 版的官方查表可在 ACS／NCCN／病理學會網站找到。乳癌、攝護腺、頭頸癌會看到「Anatomic stage」與「Prognostic stage」兩欄。請主治醫師寫下兩個分期，後續比對 NCCN 治療建議才不會誤讀。

### 第四步 — 進階：用 nomogram 算個人化風險

NCCN 與 MSKCC 都有針對單一癌別的 prediction tools ([nomograms.mskcc.org](http://nomograms.mskcc.org))，把分期、年齡、生物標記、共病等丟進去，會得到「5 年存活率」「10 年復發率」等預測。這些數字是統計平均，不是個人保命指數，但能幫助與醫師討論治療強度。

## Nomogram：補足分期表的不足

AJCC 分期把病人分成有限的格子（Stage I、II、III、IV），但同一格子內可能差距很大。Nomogram（諾莫圖）是把多個變數權重化、輸出個人化預測的工具，最早由 MSKCC 的 Kattan 等人在 1998 年發表攝護腺癌 nomogram，2008 年延伸到大腸癌復發預測，至今涵蓋 20 餘種癌別。

### MSKCC vs. AJCC 分期的差別

| 工具                    | 輸出                    | 變數數目                         | 適用對象           |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------|----------------|
| AJCC anatomic stage   | Stage I-IV            | 3 (T、N、M)                    | 全球流行病學、政策、登記   |
| AJCC prognostic stage | Stage I-IV (細分)       | 4-8 (加 grade、ER、HER2、PSA...) | 臨床預後、治療強度決策    |
| MSKCC nomogram        | 5 年／10 年機率 (連續變數)     | 5-10 (依癌別)                   | 個人化風險溝通、輔助治療決策 |
| NCCN 風險分組             | Low／Intermediate／High | 3-5 (依癌別)                    | 治療指引選擇         |

NCCN 在攝護腺癌、乳癌、淋巴瘤等癌別也有自己的風險分組（risk stratification），與 AJCC prognostic stage 概念類似。這四個工具不是擇一，而是互補使用：分期回答「我在哪一格」，nomogram 回答「在這格裡我的位置」。

#### nomogram 的限制

1. 訓練資料多為單一機構或西方人群，套用到亞洲人群時準確度可能下降。
2. 預測的是「平均風險」，個案實際結果仍受治療反應、突變影響。
3. 不能取代與主治醫師面對面討論。請把 nomogram 結果當「討論起點」，不是「最終判決」。

## 第四期不等於末期：那些「Stage IV 仍長期存活」的例子

這是本文最重要的訊息之一。Stage IV 在分期上代表「有遠端轉移」，但臨床上的「末期」（terminal）是預期壽命有限、以症狀控制為主的階段，兩者不同。以下是文獻記錄中 Stage IV 仍能長期存活的代表性情境：

- **HER2 陽性轉移性乳癌**：使用 trastuzumab + pertuzumab + 化療後，部分寡轉移、ER 陽性病人可達到「無疾病證據」（NED）並維持多年；CLEOPATRA 試驗 8 年存活率約 37%。
- **慢性骨髓性白血病（CML）**：在 imatinib 等酪胺酸激酶抑制劑問世後，10 年總存活率超過 80%，部分病人甚至能停藥維持深度分子反應。
- **EGFR 突變晚期非小細胞肺癌**：使用 osimertinib 一線治療，FLAURA 試驗中位總存活約 38.6 個月，5 年存活率仍有 20–30%。
- **寡轉移病灶（oligometastatic）**：定義為轉移病灶 ≤ 3–5 顆。乳癌、大腸癌、攝護腺癌的寡轉移病人合併局部治療（手術、SBRT 立體定位放療）+ 系統性治療，部分文獻報告 5 年存活率可達 30–50%。
- **生殖細胞腫瘤（睪丸癌）**：即使 Stage IV，含 cisplatin 的合併化療總體治癒率仍可達 70–80%。

#### 不要拿這些例子推估自己

這些是「具備特定生物標記、體能尚可、能耐受治療」的族群數據；個別病人能否走到長期存活，取決於分子亞型、寡轉移狀態、治療反應與共病。請與主治醫師討論「以我的條件，這些長期存活數據是否適用」，而非自行套用。

## 風險揭露與免責

- 本文整理 AJCC/UICC 9 版主要更新概念，並非完整查表手冊；實際 T、N、M 與分期判讀請依各癌別最新 AJCC/UICC/NCCN 文件，且應由病理科與主治醫師共同確認。
- 9 版各癌別實施日期不同（神經內分泌瘤 2024、肺癌／鼻咽癌等 2025、其他癌別陸續更新中），請查 ACS/NCCN 公告。

- 本文不取代任何個別治療建議。



## 參考文獻

---

1. Amin MB, Greene FL, Edge SB, et al. **The Eighth Edition AJCC Cancer Staging Manual: Continuing to build a bridge from a population-based to a more “personalized” approach to cancer staging.** *CA Cancer J Clin.* 2017;67(2):93-99. doi:10.3322/caac.21388
2. Giuliano AE, Connolly JL, Edge SB, et al. **Breast Cancer-Major changes in the American Joint Committee on Cancer eighth edition cancer staging manual.** *CA Cancer J Clin.* 2017;67(4):290-303. doi:10.3322/caac.21393
3. Hortobagyi GN, Connolly JL, D’Orsi CJ, et al. **Eighth Edition of the AJCC Cancer Staging Manual: Breast Cancer.** *Ann Surg Oncol.* 2018;25(7):1783-1785. doi:10.1245/s10434-018-6486-6
4. Rami-Porta R, Nishimura KK, Giroux DJ, et al. **The International Association for the Study of Lung Cancer Lung Cancer Staging Project: Proposals for Revision of the TNM Stage Groups in the Forthcoming (Ninth) Edition of the TNM Classification for Lung Cancer.** *J Thorac Oncol.* 2024;19(7):1007-1027. doi:10.1016/j.jtho.2024.02.011
5. Pan JJ, Mai HQ, Ng WT, et al. **Ninth Version of the AJCC and UICC Nasopharyngeal Cancer TNM Staging Classification.** *JAMA Oncol.* 2024;10(12):1627-1635. doi:10.1001/jamaoncol.2024.4354
6. Chauhan A, Halfdanarson TR, Bellizzi AM, et al. **Critical updates in neuroendocrine tumors: Version 9 American Joint Committee on Cancer staging system for gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors.** *CA Cancer J Clin.* 2024;74(4):359-367. doi:10.3322/caac.21840
7. Weiser MR, Landmann RG, Kattan MW, et al. **Individualized prediction of colon cancer recurrence using a nomogram.** *J Clin Oncol.* 2008;26(3):380-385. doi:10.1200/JCO.2007.14.1291
8. National Comprehensive Cancer Network. **NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology — Risk stratification and staging references.** [nccn.org](https://www.nccn.org)

引用整理協力：OpenEvidence (Ask OpenEvidence Light, 2026/05/11 查詢)

---

SOURCE <https://lin.hsiehting.com/posts/2026/cancer-staging-ajcc-9-explained/>

CITATION 林協霆. 癌症期別 Stage 1、2、3、4 怎麼分？AJCC 9th 實證版. 林協霆 · 臨床筆記. 2026/05/11. doi:10.5281/zenodo.20112703

LICENSE CC BY-NC-ND 4.0 — 文章內容依 [Creative Commons 姓名標示-非商業性-禁止改作 4.0 國際](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) 授權公開使用。

DISCLAIMER 本文整理公開發表之臨床試驗結果與 NCCN／ASCO／ESMO 治療指引，僅供醫學新知與病人衛生教育參考，不構成個別醫療建議，亦不取代主治醫師之診療判斷。實際治療決策請與您的主治團隊面對面討論。